R2.4：
[英文原文]:
ZJH-8K and TN3K were both collected at Zhujiang Hospital, Southern Medical University. Unless they are demonstrably independent in patient population, collection period, cohort composition, and clinical workflow, ZJH-8K should not be described as an external-centre cohort.

需要陈飞老师（或熟悉两库立项的同事）用临床/队列事实写进 Methods 的，是「两库到底有多独立」——请尽量按下面回答（可简短）：

1. 患者是否重叠？ TN3K 与 ZJH-8K 的 patient ID / 住院号 / 检查号能否对账？是否已知同一患者同时出现在 **TN3K** 与 **ZJH**（哪怕图像文件名不同）？若从未系统对账，请说明「未做 ID 级去重，仅做了图像级 dHash 去重」是否可写进稿。

2. 采集时段是否分开？两库大致的入组年月范围（如 TN3K 201x–201y，ZJH-8K 201a–201b）是否重叠、ZJH 是否主要是更晚的一轮专病收集或回顾性库？

3. 队列构成有何不同？除 TN3K 偏结节检测公开 benchmark、ZJH 规模更大/含更多恶性等稿面已有描述外，是否有明确的纳入排除差（如 ZJH 只要手术病理确认、TN3K 含细胞学不确定例等）可写一句？

4. 临床/成像流程是否同一？同一时期珠江医院甲状腺超声是否同一套设备与扫查规范；两库是否来自同一 **PACS**/同一科室项目，还是不同子课题、不同标注项目？

R2.5：
[英文原文]:
The Methods should specify the reference standards for nodule segmentation and benign-malignant classification, annotation procedures, annotator qualifications and adjudication of disagreements, patient-level deduplication, and handling of missing data.

解释 **ZJH-8K** 数据集（即此前 excel 里的珠江医院恶性/良性图库，稿里作分割与良恶性外测的那批）。请尽量按下面条目给可写进 Methods 的表述（可简短 bullet + 示例即可）：

1. 良恶性分类——金标准是什么？每张图的良性/恶性标签最终依据什么定：术后病理、**FNA** 细胞学，还是影像报告 + 病理复核？标签对应的是整张图上的目标结节，还是患者级一次手术结论再赋给该患者所有图？

2. 结节分割 **mask**——谁、怎么勾？参考 mask 勾画的是结节区域还是其它结构？几位超声/放射科医师参与、是否有年资/职称可写；是否双人独立勾画 + 第三人裁决或 senior 复核；用的是什么工具（如 ITK-SNAP、科室 PACS 自带等）。若只有单人勾画，也请说明。

3. 标注不一致时怎么处理？两人 mask 或良恶性不一致时，最终标签按什么规则定（取 senior、取并集、开会共识等）。

R2.10
[英文原文]:
For FTC/PTC classification, the training cohort comprised classic PTC and follicular-variant PTC, whereas the external test set comprised FTC and PTC. Because follicular-variant PTC is not equivalent to FTC, the target definition differs between training and testing. Unless this is justified as a clinically valid domain-transfer task, the reported performance may not be valid.

需要确认的是 **ZJH-8K** 恶性子集里「**FTC/PTC** 亚型」字段在数据与病历里真实含义，避免 Methods 与数据库不一致：

1. 当前标签到底是哪两类？是 **classic PTC vs follicular variant**（**FVPTC**），还是病理确认的 **PTC**（含各亚型）**vs** 真正的 **FTC**？若 excel/库里有 `FTCPTC` 或类似字段，请说明 **0/1** 或类别名各代表什么。

2. 纳入规则（病理/病历）。一例判为 FTC 或 PTC 时，依据的是术后病理报告哪一句/哪一版 **WHO** 或院内规范？FVPTC、包膜型 PTC 等是否曾计入某一类、有无重新归类过？

R2.12
[英文原文]:
For lymph-node metastasis prediction, the manuscript inconsistently refers to overall LNM, lateral LNM, and CN0/CN1 labels. The authors should clarify whether CN denotes central-compartment nodal status, whether the target is central, lateral, or any cervical LNM, whether the inputs include primary thyroid lesions, lymph nodes, or both, and how image-level predictions are aggregated at the patient level.

需要确认的是 **ZJH-8K** 上 **LNM**（**CN0/CN1**）标签与图像类型的临床定义：

1. CN0 / CN1 各表示什么？是否对应 中央区淋巴结转移（如 pN0 vs pN1a）、侧颈转移，还是任意区域淋巴结转移的汇总？请给院内或病理报告上的可操作定义（可引用一句话模板）。

2. 「**CN**」是否仅指中央区？若病历里还有侧颈清扫/侧颈转移描述，ZJH 的 CN0/CN1 是否包含侧颈信息，还是只看中央区？原稿「侧颈 LNM」表述是否应一律删除或改成什么用语？

3. ZJH-8K 用于 **LNM** 模型的图像是哪种？请确认：是否为甲状腺原发灶超声（不是单独拍的颈部淋巴结图）？若同一患者有多张原发灶图，是否共用同一 **LNM** 标签（病例级病理结论）?

4. （可选）与字段对应。 excel/库中 LNM 相关列（如 `LNM_CN01`）与上述定义的对应关系。